

41. PRÁCTICA 2 EL MARCO CÓLICO

DURACIÓN : 03:23

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Presentación de técnicas de redinamización corporal post-cesárea, centradas en el marco cólico y el peritoneo. Examen palpatorio del abdomen incluyendo la respuesta tisular y térmica para restaurar la homogeneidad fascial. Análisis del fulcro terminal, de las liberaciones tisulares y del ajuste dinámico requerido después de intervenciones pélvicas (ej. histerectomía). Metodología clínica para favorecer una reintegración tisular armoniosa.

PRÁCTICA 2: EL MARCO CÓLICO

Una **cesárea** secciona el cuerpo entre la parte superior e inferior, lo que requiere una **redinamización**. El útero representa una concentración de **peritoneo parietal posterior**. Durante el desarrollo en el peritoneo, existe una concentración y una potencia que se recentran, formando un **fulcro terminal**. Este fulcro es tanto embrionario como final, y es crucial traerlos de vuelta a la conciencia.

Durante la palpación, es esencial tomar todo el abdomen con las manos, manteniéndolas bien relajadas. Una respiración demasiado alta puede indicar una demanda de **discreción**. El **calor** que se siente es un intercambio entre el practicante y el paciente, donde el tejido comienza a dar información. Si el tejido se pone a la defensiva, la zona inferior comienza a relajarse, mientras que la parte superior aún carece de homogeneidad. El objetivo es recuperar un estado homogéneo.

Cuando el calor aumenta, todas las líneas de fuerza parecen orientarse hacia la zona uterina, como si el tejido reintegrara su **nido**. Esto ayuda al paciente a regresar a su **casa interior**, similar a alguien apegado a su tierra. En esta etapa, el practicante puede ampliar su contacto a todo el cuerpo, iniciando un **proceso terapéutico**. La integración hacia la zona uterina se fortalece, y se crea una mayor homogeneidad entre las manos.

En el caso de una **histerectomía**, la dinámica corporal cambia y el paciente puede desarrollar una **joroba de bisonte**. Esto requiere un reequilibrio en varias zonas. El trabajo se centra en puntos tisulares, permitiendo una liberación de los tejidos y un desarrollo sincronizado. Los puntos de apoyo son esenciales, especialmente para obligar al **diafragma** a trabajar de manera diferente, buscando otros espacios y aperturas.

El practicante puede entonces abordar zonas específicas como la hepática y la sigmoidea, permitiendo una relajación completa.

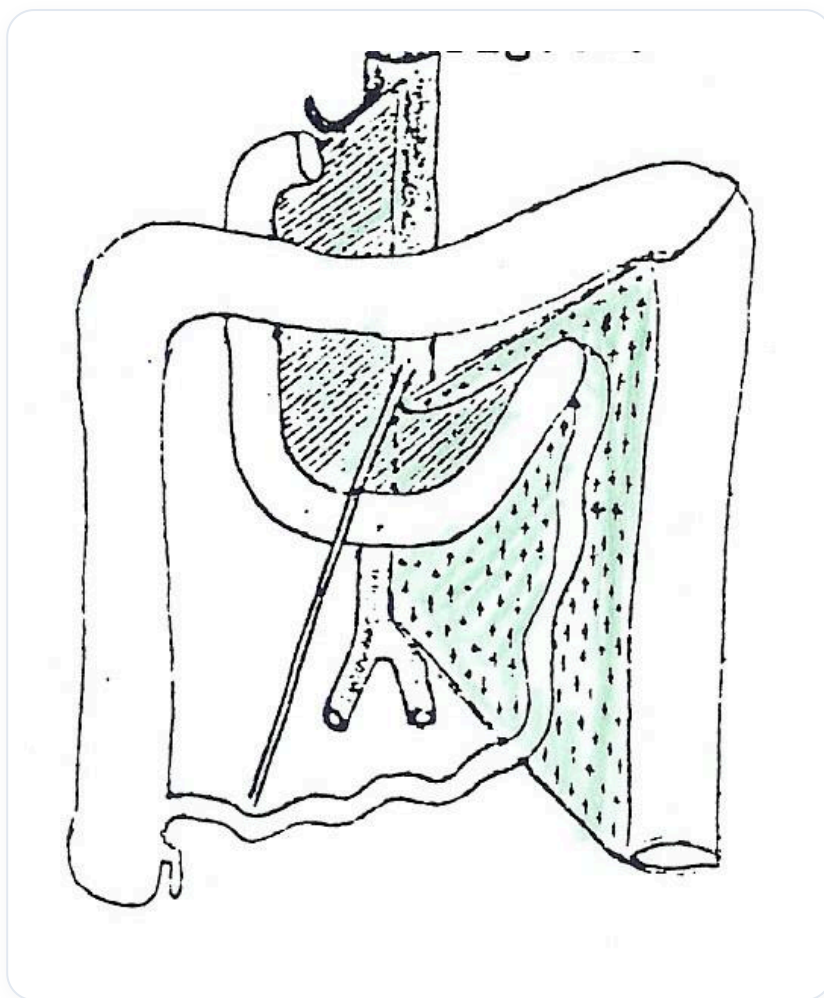


FIG. — Anatomía del colon